
**RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO**

FERFOLI®

Antianémico

1. Denominación del medicamento
FERFOLI

2. Composición cualitativa y cuantitativa

Cada comprimido está constituido por un núcleo conteniendo 90 mg de hierro (bajo la forma de sulfato ferroso) en una matriz polimérica destinado a proporcionar una liberación gradual y una capa con 1 mg de ácido fólico de liberación inmediata.
Excipientes, ver sección 6.1.

3. Forma farmacéutica
Comprimidos recubiertos.

4. Datos Clínicos

4.1. Indicaciones terapéuticas

Las principales indicaciones terapéuticas de FERFOLI son la profilaxis y tratamiento de los estados de déficit de hierro y ácido fólico, en el embarazo, puerperio y lactancia prolongada. El hierro está indicado en todas las situaciones de carencia, sea por aporte insuficiente sea por necesidades aumentadas. Está particularmente indicado en la prevención y tratamiento de las anemias de la gestación y puerperio. El ácido fólico se utiliza para prevenir o tratar los déficits que pueden aparecer en algunos estados fisiológicos (por ejemplo la gestación, la lactancia y el crecimiento), en diversas patologías (por ejemplo, anemias macrocíticas y megaloblásticas, síndromes de malabsorción: esprue, esteatorrea idiopática, enfermedad de Whipple), y en pacientes bajo terapéutica anticonvulsivante y alcohólicos.

4.2. Posología y forma de administración

Excepto otra indicación médica, ingerir 1 comprimido de FERFOLI al día, entero, con agua o zumo de fruta (evitar la leche), preferentemente con el estómago vacío. En caso de intolerancia gástrica se recomienda la ingesta después de las comidas (almuerzo o cena). La duración del tratamiento será establecida por el médico.

En caso de olvido de una o más dosis continuar normalmente el tratamiento, de acuerdo con la prescripción.

4.3. Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida al producto.

Sobrecarga de hierro en el organismo (hemocromatosis o hemólisis crónica). Anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12.

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

Excepcionalmente, puede aparecer hipersensibilidad al ácido fólico.

Utilizar con precaución en caso de afecciones agudas del tracto digestivo. La eventual aparición de heces de color oscuro es normal. Esta especialidad contiene lactosa.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

El uso concomitante de antiácidos reduce la absorción de hierro. Preparaciones de hierro oral pueden interferir con la absorción de metildopa, algunas quinolonas (ciprofloxacino, norfloxacino, ofloxacino), penicilamina, tetraciclinas y tiroxina. Si es necesaria la administración simultánea de los fármacos, respetar al menos 2 horas de intervalo. La respuesta a la terapéutica con hierro puede ser retrasada por el cloranfenicol. La vitamina C aumenta la absorción del hierro. Preparaciones de hierro oscurecen las heces y pueden interferir en los tests de detección de sangre oculta en las heces.

En enfermos con carencia de folato, la terapéutica con ácido fólico puede aumentar el metabolismo de la fenitoína, dando como resultado la disminución de sus concentraciones séricas. Aunque esta interacción no sea, habitualmente, clínicamente importante, puede aparecer un aumento de frecuencia de las crisis, en algunos enfermos.

La vitamina C aumenta y el uso concomitante de antiácidos disminuye la absorción de hierro. El hierro disminuye la absorción de tetraciclinas y viceversa, y disminuye la absorción y altera el

metabolismo de la metildopa, pudiendo verse afectada su eficacia antihipertensora. La administración concomitante de preparaciones de hierro oral puede interferir en la absorción de algunas quinolonas (ofloxacino, ciprofloxacino, norfloxacino). La respuesta terapéutica al hierro puede ser retrasada por el cloranfenicol. El efecto cuprodiurético de la penicilamina es afectado por el hierro oral, probablemente por disminución de su absorción. Si resulta necesario, estos productos deben ser administrados con, por lo menos, 2 horas de intervalo.

El ácido fólico puede interferir con los antiepilépticos, pudiendo aumentar la frecuencia de las crisis.

4.6. Embarazo y lactancia

La utilización de hierro y ácido fólico durante el embarazo y la lactancia es segura, siendo además éstas, dos de sus indicaciones.

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar máquinas

No fueron observados efectos sobre la capacidad de conducción y utilización de máquinas.

4.8. Reacciones adversas

Posibilidad de intolerancia digestiva debida al hierro que se manifiesta por dolores abdominales, ardor epigástrico, náuseas, estreñimiento o diarrea relacionada con la ingesta de hierro. Muy raramente pueden observarse fenómenos de hipersensibilidad al ácido fólico que se manifiestan con broncospasmo, eritema, fiebre o prurito.

La aparición de heces de color oscuro no tiene ningún significado patológico y está relacionado con la excreción de hierro.

4.9. Sobredosis

La ingesta masiva, casi siempre en niños, puede ocasionar problemas graves resultantes de la sobredosis de hierro, ya que el ácido fólico no es tóxico. La sintomatología se manifiesta por irritación digestiva, náuseas, vómitos y shock. En caso de intoxicación, como medida inmediata, hacer lavado gástrico con bicarbonato sódico al 1%.

5. Propiedades farmacológicas

5.1. Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico- Antianémicos

Código ATC: B03A D03 – Hierro (sulfato ferroso) en asociación con ácido fólico.

FERFOLI es una especialidad farmacéutica que contiene como principios activos dos importantes micronutrientes- el hierro y el ácido fólico. El hierro se encuentra en el producto bajo la forma de sulfato ferroso, el cual es liberado lentamente a partir del núcleo del comprimido, mientras que el ácido fólico, presente en la capa, se libera más rápidamente.

El ion hierro es indispensable para la síntesis de la hemoglobina y mioglobina - compuestos necesarios para el transporte y utilización del oxígeno. El hierro entra también en la composición de un gran número de enzimas implicadas en la transferencia de energía, teniendo como ejemplo la oxidasa, la xantina oxidasa y el succinato dehidrogenasa. El déficit de hierro, que provoca uno de los más frecuentes, si no el más frecuente, cuadro de carencia, es debido a una multitud de razones que conducen a una ingesta insuficiente (anorexia, enfermedades gastrointestinales, dietas pobres) o a un aumento de las pérdidas (menstruación, pérdidas ocultas). La incidencia de carencia de hierro en mujeres menstruantes está evaluada en el 10-20%.

El *ácido fólico* - ácido pteroilglutámico - es una vitamina indispensable en numerosas reacciones metabólicas esenciales para la vida como la síntesis de las purinas, síntesis de nucleótidos pirimidínicos, interconversión de ácidos aminados (serina en glicina, histidina en ácido glutámico, homocisteína en metionina).

La hematopoyesis es el punto eje de la actuación conjunta de *Hierro y Ácido fólico*. Siempre que aquella esté aumentada hay movilización de *hierro* y de folato de las reservas orgánicas. También en caso de pérdida de sangre hacia el exterior, cualquiera que sea la etiología o la localización de la hemorragia, esa movilización es puesta en marcha. Para que el balance se mantenga suele comprobarse un aumento del aporte en la dieta de estos nutrientes que, además, existen en pequeñas cantidades en muchos alimentos. Necesidades o pérdidas aumentadas y no compensadas por la alimentación son las causas principales de anemia. Hay que tener presente la posibilidad de que una anemia ferropénica puede acompañarse de un déficit profundo

de folatos, no olvidando que el déficit de hierro puede disimular el déficit de folatos y así dificultar el diagnóstico de esta última carencia y, a su vez, el déficit de folatos puede disminuir la reticulocitosis inducida por la administración de hierro. En ambos casos la corrección de la carencia de uno de estos dos nutrientes implica siempre un aumento del consumo del otro que debe, por consiguiente, existir en cantidad suficiente para facilitar la hematopoyesis.

Como en el embarazo el interés de la asociación hierro+ácido fólico está relacionada no solamente con el metabolismo hemoglobínico sino con todo el proceso de desarrollo fetoplacentario, su utilización preventiva es admitida mundialmente.

5.2. Propiedades farmacocinéticas

Hierro: La absorción de *hierro* ocurre predominantemente en el duodeno y yeyuno y es influenciada por diversos factores de los cuáles se destacan: el grado de reservas existentes, el ritmo de la eritropoyesis y la forma por la cuál es administrado (el sulfato de hierro es la sal que presenta mejor biodisponibilidad). De hecho, en el hombre y en la mujer posmenopáusica el metabolismo del *Hierro* se realiza en sistema cerrado, es decir, la mayor parte de hierro liberado por la destrucción de los eritrocitos envejecidos es de nuevo utilizado por lo que en estos casos la anemia ferropénica está relacionada casi siempre con pérdidas sanguíneas patológicas. Sin embargo, en las mujeres en edad reproductiva, y considerando la pérdida mensual debida a la menstruación, las necesidades son el doble de las del hombre o la mujer menopáusica. Variaciones en la cantidad del flujo menstrual y/o en su frecuencia interfieren en los depósitos orgánicos de hierro y son una causa relativamente frecuente de anemia. Por otro lado el embarazo es la situación fisiológica en la cuál las necesidades de hierro están extraordinariamente aumentadas - un total de aproximadamente 800 mg en la gestación normal - especialmente en el 3º. trimestre, periodo en que las necesidades fetales son máximas. Esto obliga a la utilización cada vez mayor de las reservas maternas que, en regla, no son suficientemente grandes (± 300 mg) para cubrir dichos valores y, por su lado, la alimentación muy raramente contiene una cantidad de hierro que permita obtener los 6-7 mg diarios necesarios.

Ácido fólico: El *Ácido fólico* es absorbido en la parte proximal del intestino delgado y rápidamente reducido a ácido tetrahidrofólico, el cuál acepta cadenas monocarbonadas en su posición 5 ó 10 para formar las siguientes coenzimas activas: ácidos 5-metil-tetrahidrofólico, 5-formil-tetrahidrofólico, 10-formil-tetrahidrofólico, 5,10-metenil-tetrahidrofólico, 5,10-metileno-tetrahidrofólico, 5-formimino-tetrahidrofólico e 10-hidroximetil-tetrahidrofólico. Los diversos compuestos así formados se almacenan en las células como poliglutamatos, que no difunden en el espacio extracelular.

El *ácido fólico* es una vitamina hidrosoluble, siendo la vía renal su principal vía de eliminación. Como la mayor parte de la absorción se desarrolla en la parte proximal del intestino delgado es frecuente la aparición de deficiencias de folatos cuando hay patología del yeyuno (esprue, esteatorrea). También en el alcoholismo agudo y crónico, en enfermedades caracterizadas por un "turnover" elevado, como por ejemplo, las anemias hemolíticas hereditarias, en enfermos que toman inhibidores de la reductasa del dehidrofolato como el trimetoprim y el metotrexato, o en enfermos que toman medicamentos que interfieren con la absorción y almacenamiento de folatos en los tejidos, como los anticonvulsivantes y los contraceptivos orales, pueden aparecer estados carenciales.

5.3. Datos preclínicos de seguridad

El hierro y el ácido fólico son ampliamente conocidos y usados en la clínica. Los datos de los estudios animales disponibles no ponen en duda la seguridad del producto.

6. Datos farmacéuticos

6.1. Lista de excipientes

Almidón de maíz, lactosa monohidrato, povidona, talco, ácido cítrico anhidro, estearato de magnesio, Eudragit RLPO, Opadry OY-S-33019.

6.2. Incompatibilidades

Debido a la ausencia de estudios de incompatibilidad, este medicamento no debe ser mezclado con otros.

6.3 Periodo de validez

3 años.

6.4. Precauciones especiales de conservación

No conservar a temperatura superior a 30°C. Conservar en el envase original.

6.5. Naturaleza y contenido del recipiente

Envase de cartón conteniendo blisters de Alu/Alu, con 10 comprimidos cada. Cada caja contiene 60 comprimidos y un prospecto.

6.6. Instrucciones de uso/manipulación (y eliminación)

No se aplica.

La eliminación de los productos no utilizados o de los envases se establecerá de acuerdo con las exigencias locales.

7. Titular de la Autorización de Introducción en el Mercado

BIAL - Portela & C^a, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugal

8. Número de Autorización de Comercialización

99-0977

9. Fecha de la primera autorización/renovación de la autorización

Fecha de la primera autorización: 25/01/2002

Fecha de la última renovación de la autorización: 04/02/2019

10. Fecha de la revisión del texto

11/2020